

- 70～90% に合併する。典型例では慢性副鼻腔炎で発症し、続いて下気道の病変が形成される。
- これらの臨床症状は、先述の副鼻腔炎の合併と、後述する画像所見と合わせて3つの必須項目とされる。
- TLR は受容体を介して微生物の共通した分子構造を認識して生体防御機構を誘導する。
- × マクロファージや樹状細胞などの抗原提示細胞に多く発現している。
- × IgM ではなく IgA である。
- ムチンのコア蛋白である MUC5AC の増加が気道の粘液分泌過剰につながる。
- × 呼吸細気管支を中心とした末梢側の細気管支の炎症が主座となる。
- 細気管支にはリンパ球の集積や濾胞形成がみられる。
慢性炎症には CD8+T 細胞やマクロファージが寄与する。
- × 喀痰中には好中球が多く、気道の好中球過剰集積を反映する。これが活性酸素や蛋白分解酵素を放出し組織障害を惹起する。
- 全肺野に認め、やや中下肺野に多い傾向がある。
- 2～5 mm の小葉中心性の粒状影は画像所見の key word である。
- × 初期にはないが、疾患が進行すると認める。
- × 気道免疫を反映して、IgA の上昇がみられる。赤沈の亢進、CRP や白血球数の増加もみられる。
- ヒト赤血球凝集法で 64 倍以上を有意とする。
- 抗菌薬に対する耐性菌が検出されることもある。

3